BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ÁP XE VÁCH NGĂN

Mã đề xuất CS-TMH-06; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: J34.0

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Hỏi bệnh: Bệnh có sưng đau mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi không, có sốt không, có khó thở không ? có bít tắt bên mũi nào không?

- Tiền sử: Có tiểu đường không ? Có từng bị chấn thương va đập không?

- Thăm khám: bênh mũi sưng to, đau nung mủ, sốt bít hốc mũi…

Hỗ trợ khám và cận lâm sàng theo bác sĩ; không mặc định CT cho mọi người bệnh.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Bệnh đau do sưng tấy vách ngăn

2.2. Người bệnh sốt cao do nhiễm trùng

2.2.Nguy cơ xảy ra biên biến chứng

2.3. Người bệnh lo lắng về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Giảm đau cho người bệnh

Báo bác sĩ TMH sớm khi nghi áp xe/tụ máu vách ngăn. Theo dõi sinh hiệu, đau và dấu nhiễm trùng; chuẩn bị dẫn lưu theo kế hoạch bác sĩ, không chỉ giảm đau để chờ mủ to.

3.2.Giảm sốt cho người bệnh

- Thực hiện thuốc hạ sốt hướng dẫn lau mát cho người bệnh, năm phòng thoáng mát

3.3.Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng:

Dẫn lưu/chọc hút và kháng sinh do bác sĩ quyết định theo tình trạng; điều dưỡng hỗ trợ, theo dõi và chăm sóc dẫn lưu nếu có. Không tự sờ nắn, bóp mủ; báo khi sốt tăng, sưng lan hoặc dấu thần kinh.

3.3.Cung cấp cho người bệnh kiến thức:

- Hướng dẫn người bệnh uống thuốc, vệ sinh sạch sẽ khi nằm viện , không tự ý bôi thuốc, đắp thuốc lên chỗ áp xe, không tự ý nặng mủ, nếu thấy bất thường báo ngay cho nhân viên y tế

Xuất viện theo quyết định bác sĩ với lịch tái khám cụ thể; không đợi hết thuốc nếu chảy máu, sưng tăng, đau đầu, rối loạn thị giác hoặc sốt.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Thực hiện các can thiệp theo kế hoạch trên, ghi thời điểm và đáp ứng; thuốc theo y lệnh, kỹ thuật theo quy trình riêng và phạm vi được phép.

5. Đánh giá

-Người bệnh cải thiện

- Hết nghẹt mũi, mũi hết sưng

- Bệnh hiểu biết về bệnh

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……